

Reducción de tiempos de admisión y espera en consulta externa

Clínica Santa Lucía del Valle

Dato	Detalle
Código de proyecto	PC-2025-033
Cliente	Clínica Santa Lucía del Valle, clínica privada de especialidades con 38 consultorios y 60 camas
Sector	Salud – clínicas y hospitales privados
Ubicación	Valle de los Chillos, Quito
Periodo de ejecución	6 de octubre de 2025 al 27 de febrero de 2026 (21 semanas)
Gerente de proyecto	Ing. Martín Aguirre
Equipo consultor	1 gerente, 1 consultora senior en procesos de salud, 1 consultor, 1 analista de datos
Contraparte del cliente	Dirección Médica y Jefatura de Admisiones
Estado	Cerrado – aceptado por el cliente el 6 de marzo de 2026

1. Resumen ejecutivo

La Clínica Santa Lucía del Valle recibía un número creciente de quejas por tiempos de espera en consulta externa, que se habían convertido en el principal motivo de insatisfacción en sus encuestas. El proyecto intervino el recorrido completo del paciente, desde el agendamiento de la cita hasta el ingreso al consultorio, con foco en el proceso de admisión, que era el principal cuello de botella.

Gracias al rediseño del agendamiento, la implementación de la pre-admisión digital y la reorganización de las ventanillas de admisión, el proyecto redujo el tiempo de espera promedio de los pacientes en un 30% y el tiempo de admisión en más de la mitad. La satisfacción de los pacientes, medida mediante NPS, se duplicó.

2. Contexto y objetivos

La consulta externa atiende en promedio 9.800 citas al mes en 22 especialidades. Antes del proyecto, los pacientes debían llegar 30 minutos antes de su cita para completar la admisión en ventanilla, donde se registraban sus datos, se verificaba la cobertura del seguro y se realizaba el cobro. Las citas se agendaban en bloques fijos de 20 minutos para todas las especialidades, sin considerar las diferencias reales de duración, lo que generaba acumulación de pacientes en las horas pico.

Objetivos acordados con el cliente:

- Reducir el tiempo total de espera del paciente, desde su llegada hasta el ingreso al consultorio, en al menos 20%.
- Reducir el tiempo de admisión en ventanilla a menos de 8 minutos.
- Lograr que al menos 30% de los pacientes realice su pre-admisión en línea.

- Reducir el ausentismo de citas por debajo del 18%.

3. Alcance

El proyecto abarcó la consulta externa en todas sus especialidades. Los servicios de emergencia, hospitalización e imagenología quedaron fuera del alcance. El desarrollo del formulario de pre-admisión en línea fue realizado por el proveedor del sistema hospitalario del cliente, con base en el diseño funcional elaborado por el equipo consultor.

4. Metodología

Se utilizó un enfoque Lean aplicado a salud, complementado con análisis de colas para dimensionar las ventanillas y los bloques de agenda. El trabajo se organizó en tres fases:

- **Diagnóstico (semanas 1 a 5):** seguimiento presencial de 420 pacientes para medir los tiempos de cada etapa, mapeo del recorrido del paciente y análisis de la agenda por especialidad.
- **Diseño y piloto (semanas 6 a 12):** rediseño de la agenda con bloques diferenciados por especialidad, diseño de la pre-admisión digital y piloto en las especialidades de pediatría, ginecología y traumatología.
- **Despliegue y medición final (semanas 13 a 21):** extensión a todas las especialidades, recordatorios automáticos de cita por mensajería y medición final.

5. Iniciativas implementadas

5.1 Agenda diferenciada por especialidad

Se reemplazaron los bloques fijos de 20 minutos por bloques de 15, 20 o 30 minutos según la duración real observada de cada especialidad, y se reservaron espacios para pacientes de control y procedimientos cortos.

5.2 Pre-admisión digital

El paciente puede actualizar sus datos, validar su seguro y pagar su copago en línea hasta dos horas antes de la cita. Quienes completan la pre-admisión se dirigen directamente a la sala de espera de la especialidad.

5.3 Reorganización de ventanillas

Se separó una ventanilla exclusiva para pacientes con pre-admisión y casos rápidos, y se ajustó el número de ventanillas abiertas por franja horaria según la demanda estimada con el análisis de colas.

5.4 Recordatorios y confirmación de citas

Se implementaron recordatorios automáticos 48 y 24 horas antes de la cita con opción de confirmar, reprogramar o cancelar, lo que permitió liberar espacios para pacientes en lista de espera.

6. Resultados

La línea base corresponde a la medición del diagnóstico, en octubre de 2025. El resultado corresponde a la medición final realizada en febrero de 2026, con todas las iniciativas operando en todas las especialidades.

Indicador	Línea base	Meta	Resultado	Variación
Tiempo total de espera del paciente	52 min	reducción ≥ 20%	39,5 min	-24%
Tiempo de admisión en ventanilla	14 min	< 8 min	6 min	-57%
Pacientes con pre-admisión digital	0%	≥ 30%	41%	+41 pp

Indicador	Línea base	Meta	Resultado	Variación
Ausentismo de citas	22%	< 18%	15%	-7 pp
Satisfacción del paciente (NPS)	18	sin meta	37	+19 puntos

Nota sobre el tiempo de espera: la medición preliminar de diciembre de 2025 arrojó una reducción del 30%. La medición final de febrero de 2026, que incluye la temporada de mayor demanda por el inicio del año escolar, arroja una reducción del 24%, que constituye el dato oficial de cierre del proyecto.

Se cumplieron los cuatro objetivos del proyecto. El tiempo de espera muestra mayor variabilidad en traumatología y dermatología, donde la demanda supera la capacidad de consultorios en horario de la mañana.

7. Lecciones aprendidas

- **Involucrar a los médicos desde el diagnóstico.** El rediseño de la agenda generó inicialmente rechazo de algunos especialistas. Presentarles los tiempos reales de sus propias consultas, medidos en el diagnóstico, facilitó el acuerdo sobre los nuevos bloques.
- **La medición manual de tiempos tiene límites.** El seguimiento presencial de pacientes es costoso y difícil de repetir. Se recomendó al cliente registrar automáticamente las marcas de tiempo de llegada, admisión e ingreso a consulta para dar seguimiento continuo.
- **La adopción digital requiere acompañamiento.** La pre-admisión creció de forma sostenida solo después de ubicar personal de apoyo en la entrada durante las primeras semanas para guiar a los pacientes.

8. Recomendaciones y próximos pasos

- Implementar el registro automático de marcas de tiempo en el sistema hospitalario para medir la espera de forma continua.
- Evaluar la ampliación de horarios o consultorios en traumatología y dermatología.
- Extender el modelo de pre-admisión a imagenología y laboratorio.
- Establecer una meta de pre-admisión digital de 60% para el cierre de 2026.